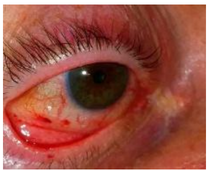
累及多器官病变考虑心内膜炎和SLE

三、持续性菌血症、变态反应、栓塞等多系统损害



淤点

1.**发热（最常见）**：器质性心脏病出现发热要考虑有感染性心内膜炎的可能

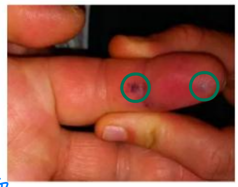
e.g 主动脉关闭不全患者某一天突然发热了,警惕感染性心内膜炎

2.**心脏杂音**（85%）

草
主闭 → 亚心炎

①基础瓣膜病或先心病 本身就可有杂音

②心内膜炎所致瓣膜损害（主要引起主闭） 从主闭到主闭 杂音出现变化



Osler结

血液流经心瓣膜上的赘生物,啪一下RBC撞烂

3.贫血（睑结膜苍白）、**杵状指**、**脾大**、细菌性动脉瘤

无特异性　硬硬支支炎炎脓脓没事哎

炎症性肠病(肠外表现出现杵状指,杵状指与疾病不共存)

4.周围体征 本质上是变态反应,免疫复合物沉积在微小血管,引起炎症,导致微小血管发生很小的出血

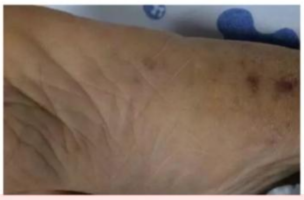
①瘀点：锁骨上皮肤、口腔黏膜、睑结膜常见

②指/趾甲线状出血

③Janeway（闻）损害：手掌/足底的无痛性出血红斑

④Osler 结：指/趾垫的红紫色痛性结节 可能栓塞导致

⑤Roth 斑：视网膜的中心呈白色的卵圆形出血斑 （揉眼睛）



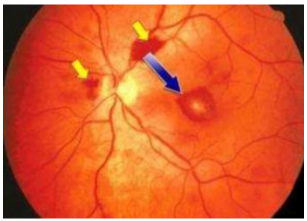
Janeway损害

腱索断裂常见于感染性心内膜炎 VS 乳头肌断裂常见于心肌梗死

5.**心衰**（最常见并发症）：主要是主闭所致。若腱索断裂或瓣叶穿孔可致急性左心衰

所有循环系统的并发症

和乳头肌是控制瓣叶闭合的



Roth斑

尿沉渣RBC>3个/HP

6.**肾小球肾炎**：蛋白尿、血尿（多为镜下血尿）等

入球动脉口径>>出球动脉口径
免疫复合物易沉积

VS 肉眼血尿往往是发生栓塞引起肾梗死

小结亚心炎:发热、心脏杂音、多系统损害→oh（Osler） rose（Roth） 血（出血 贫血） 皮（脾大） 除（杵状指） 神（肾小球肾炎） 牛 细菌性动脉瘤

可能可能最可能：青年人多见，发热、心脏杂音、多系统损害

	急性感染性心内膜炎	亚急性感染性心内膜炎
发病率	少见	多见
致病菌	金（jin）葡菌等毒力较强 草 室缺 → 亚心炎 →（脱落）右心室 → 肺	**草绿色链球菌**等毒力较弱 （草绿色链球菌从口腔进入血流的机会频繁、黏附性强，如**拔牙**） 拔草
病变部位	正常心瓣膜即可侵犯	侵犯病变心瓣膜（如风湿病）风湿病本身导致瓣膜损害
赘生物（含菌） 细菌代谢导致赘生物松软	脑袋血流最丰富 视网膜动脉栓塞 ①脱落主要导致体循环动脉栓塞：**脑栓塞最常见**、失明、急性心梗、**肾梗死（肉眼血尿）** 冠状动脉栓塞 没有下肢深静脉血栓形成的病史 ②脱落也可致**肺栓塞**（**左向右分流的先天病**、或右心内膜炎）	
	易脱落形成栓子导致败血性/感染性梗死（如引起脑栓塞，可继发脑脓肿、化脓性脑膜炎）	易脱落形成栓子导致无菌性梗死 小草太弱了
血白细胞	↑	多↑、可正常
发热	寒战高热	往往不是高热多<39 度、持续发热 持续性菌血症
心脏杂音	强度和性质易变化或出现新的杂音	强度和性质较稳定 ttsx
多系统损害	**Janeway 损害**、急性左心衰、中毒性脑（感染性梗死）病、脑脓肿、化脓性脑膜炎多见（Ji）	多数周围体征、贫血、杵状指、脾大、细菌性动脉瘤、肾小球肾炎多见 需要一定时间
抗生素	苯唑西林、**氯唑西林或头孢唑林**等头孢呋辛 耐酶青霉素　一代头孢　二代头孢	**青霉素**等

天天师兄

VS风湿病(变态反应性疾病)赘生物不含菌,不容易脱落